

요관 재건술은 신장(콩팥)에서 방광으로 소변을 운반하는 관인 요관이 막히거나 좁아진 경우 이를 복원하여 소변 배출을 회복하고 신장을 보호하는 수술입니다. 수술 방법은 협착의 위치와 길이에 따라 다르며, 요관 끝을 직접 봉합하거나 조직 이식편을 사용하거나 장 분절을 이용할 수 있습니다.

이 수술에 대하여

요관의 **협착**(흉터로 인한 좁아짐)은 소변을 가두어 신장에 부담을 줍니다. 협착의 정도에 맞춰 수술 방법을 선택합니다.

- **짧은 협착** — 병변 부위를 제거한 뒤 건강한 양 끝을 봉합하거나, 요관을 방광에 재연결합니다(필요시 방광을 위로 당겨 연결).
- **긴 협착** — 요관을 **이식편**으로 넓힙니다. 주로 볼 안쪽 점막(협부 점막 이식편)을 사용합니다.
- **매우 긴 손상** — 본인의 **장 분절**로 손실된 요관 부위를 대체합니다.

치유되는 동안 요관을 열어 두기 위해 부드러운 **요관 스텐트**를 삽입합니다. 수술은 주로 **로봇 또는 복강경**(최소침습) 방식으로 시행하며, 경우에 따라 개복수술을 합니다. 성공률이 높습니다.

안전한가요?

이 수술들은 검증된 효과적인 치료법이며, 환자의 해부학적 특성에 맞게 시행됩니다. 모든 큰 수술과 마찬가지로 출혈, 감염, 일시적인 소변 누출(보통 스텐트와 배액관으로 관리) 등의 위험이 있습니다. 협착이 재발하는 경우는 드뭅니다. 장 분절을 사용한 경우 장이 회복되기까지 며칠이 필요하며, 소변에 약간의 점액이 섞일 수 있습니다.

용어 설명

요관

신장에서 방광으로 소변을 운반하는 관.

협착

흉터로 인해 좁아진 부위로 소변 흐름을 방해합니다.

요관 스텐트

치유되는 동안 요관을 열어 두는 부드러운 내부 관 ("더블-J").

이식편

요관을 넓히기 위해 사용하는 본인의 조직 조각(주로 볼 안쪽 점막).

장 분절

긴 결손 부위를 메우기 위해 사용하는 본인의 짧은 장 조각.

요관 재이식

요관을 방광에 다시 연결하는 수술.

수신증

폐색으로 소변이 역류하여 신장이 팽창한 상태.

로봇/복강경

작은 절개 몇 개로 시행하는 최소침습 수술.

아픈가요? 수술은 전신마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 못합니다. 수술 후에는 절개 부위에 통증이 있으며, 내부 스텐트로 인해 절박뇨나 가벼운 옆구리 불편감이 생길 수 있습니다. 장 분절을 사용한 경우 장이 회복되기까지 며칠이 걸립니다. 대부분 1~3일간 입원하며, 수술 시간은 수술 방법에 따라 다릅니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취**로 진행됩니다 — 금식 및 복용 중인 약(혈액 희석제 포함) 중단에 관한 모든 수술 전 지시를 따르세요.
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- **금연하세요** — 흡연은 회복을 늦춥니다. 장 분절을 사용할 경우 장 정결이 필요할 수 있으며, 협부 점막 이식이 예정된 경우 구강 위생을 잘 관리하세요.
- **약 4~6주간 스텐트**가 삽입되므로 일정을 조정하고, 귀가할 때 함께할 사람을 준비하세요.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- **혈액 희석제** 복용 중이거나 현재 감염이 있는 경우
- 과거 복부·골반 수술 또는 방사선 치료 경험이 있는 경우

수술 과정

- 1 마취 후 잠든 상태에서 항생제를 투여합니다.
- 2 집도위가 최소침습 또는 개복 절개를 통해 협착 부위에 접근합니다.
- 3 스텐트 위에서 요관을 복원합니다 — 끝을 봉합하거나, 이식편으로 넓히거나, 장 분절로 연결합니다.
- 4 필요시 소형 배액관을 유지한 후 절개를 봉합합니다.

수술 후

- 보통 **1~3일** 이내에 퇴원합니다.
- **스텐트는 약 4~6주** 동안 체내에 유지하다가 외래에서 방광경으로 제거합니다.
- 절박뇨, 가벼운 옆구리 불편감, 분홍빛 소변은 스텐트로 인한 **정상적인 증상**입니다.
- 장 분절을 사용한 경우 장이 회복될 때까지 가볍게 식사하세요. 몇 주간 **무거운 물건을 들지 마세요**.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 심하거나 악화되는 옆구리·복부 통증
- 심한 출혈 또는 소변이 전혀 나오지 않는 경우
- 지속적인 구토, 또는 방귀·배변이 없는 경우(장 분절 사용 후)
- 절개 부위의 점점 심해지는 발적·통증·분비물

기억할 세 가지

1. 요관 재건술은 막힌 요관을 열어 신장을 보호합니다. 수술 방법(직접 봉합·협부 점막 이식·장 분절)은 환자에게 맞게 결정되며, 내부 스텐트 위에서 시행됩니다.
2. 준비: 금식·복약 지시를 따르고, 감염을 먼저 치료하고, 금연하며, 4~6주간의 스텐트 기간을 준비하고 귀가 동반자를 마련하세요.
3. 스텐트 제거 전까지 절박뇨가 있을 수 있습니다. 발열·심한 통증·심한 출혈·소변 불통·수술 후 장 활동 없음이 나타나면 즉시 연락하세요.